

Fecha Última Actualización: 23-03-2022 15:59:02

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Víctor Manuel Sánchez Cifuentes
Edad : 75a 0m 15d
Dirección : Pje Julio Li # 1716

Rut : 5.088.522-4
Fecha Nacto: 08/03/1947
Comuna : San Ramón

N° Archivo : 1406868
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 6169 1777

N° Epicrisis
296333

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 14/02/2022 18:37

Días Estadía: 37

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básicas

Fecha Egreso : 23/03/2022 15:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

- Mórbidos: Cardiopatía coronaria con CRM con 4 By pass (2014). Obeso, DLP, HTA., hipotiroidismo.
- Quirúrgicos: 2016 accidente de tránsito con fractura de pierna operado
- Fármacos: Aspirina 100x1 - Atenolol 25x1 - Losartán 25x1 - Atorvastatina 40x1 - Levotiroxina 25x1
- Alergias: Atropina, papaverina, morfina (descritos en DAU)
- Hábitos: TBQ: \$ hace 40 años
- Hospitalizaciones recientes: No.
- Inmunizaciones: covid19, 3

Historia:

Derivado desde CESFAM Bernardo Leighton en donde consulta en su día +9 de síntomas respiratorios altos, día +7 antígeno COVID (+). Ingresó durante la madrugada del 15/02 en malas condiciones, saturando 81% ambiental asociado a disnea y dolor torácico que refiere como opresivo pero solo durante episodios de tos. Sin otros síntomas asociados.

Se maneja con 300 mg de hidrocortisona, NBZ con bromuro de ipatropio y O₂. Se deriva con mascarilla de no recirculación a 15 a su ingreso a SU CASR saturando 92%. Se intenta conexión a CNAF con 60/60 (Flujo/FiO₂) con fracaso precoz en contexto de saturación límite y mala mecánica ventilatoria, por lo que se realiza IOT, sedación profunda e inicio de VMI; con posterior traslado a UCI para continuar manejo y estudio.

Ingresó a UCI sedado con Fentanilo/Midazolam (sin BNM), sin requerimientos de DVA, afebril. En VMI modo V/AC bien acoplado a ventilador con FiO₂ 60%.

EKG de ingreso: BCRI con Sgarbossa (-). (Trop US Negativa).

TAC de tórax 14/02/2022: Extensos focos de condensación con densidad en vidrio esmerilado bilaterales de distribución predominantemente periférica identifican algunas áreas con engrosamiento septal interlobulillar y bandas atelectásicas en ambas bases pulmonares. Pequeñas lesiones quísticas subpleurales y otras periféricas de predominio en ambos lóbulos superiores, que pudiese corresponder a enfisema subyacente.

Evolución durante la hospitalización

-Hemodinamia: al ingreso con hemodinamia autosostenida, se reinician betabloqueadores en dosis bajas. Requirió dosis bajas de NAD en relación a sedoanalgesia profunda, siendo suspendida tras suspensión de propofol. Se realizó terapia depleitiva y

Fecha Epicrisis : 23/03/2022 15:59

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 23-03-2022 15:59:02

Página 2 de 3

evoluciona hemodinámicamente estable, sin conflicto.

- Respiratorio: requiere Prono x 48 hrs del 15 al 17/02, con buena respuesta tras regreso a supino. BNM suspendido 24 hrs después. El 22/02 por sospecha de sobreinfección bacteriana/TEP se solicita AngioTAC de tórax que confirmó TEP subsegmentario, iniciándose anticoagulación con heparina. Extubado el 25/02 a las 10 am, se apoya en forma profiláctica con VMNI, pero paciente no la tolera por vómitos. Evoluciona con requerimientos de oxígeno en disminución, logrando su suspensión el 13/03, sin nuevo conflicto.

- Neurológico: posterior a extubación cursa con delirium mixto, que se maneja con medidas ambientales, antipsicóticos y dexmedetomidina con buena respuesta y con posterior suspensión de fármacos.

- Infeccioso: NAC COVID-19 grave con requerimiento de VMI. Completó protocolo RECOVERY y recibió ampicilina-sulbactam empírico por 9 días. Evoluciona favorablemente, logrando extubación el 25/02 y con requerimientos de oxígeno que disminuyen progresivamente hasta la suspensión. Cursa NAVM por P. aeruginosa MS + E. coli MS, la cual recibe Imipenem ajustado a Ciprofloxacino con antibiograma, completando 7 días de tratamiento a dosis plenas, con parcial respuesta, con parámetros inflamatorios estacionarios y subfebril. El día 08/03 presenta peak febril y aumento de requerimientos de oxígeno, por lo que se toma HC (-), UC (-) y se inicia imipenem empírico. Se solicita TAC de tórax que mostró secuelas de neumopatía por COVID y coágulos en ambos sistemas pielocaliciarios y signos de nefritis en el riñón izquierdo, probablemente de etiología inflamatoria infecciosa. Completó 7 días de Imipenem con buena respuesta, sin nuevos peaks febriles, con parámetro inflamatorios bajos. UroTAC de control con leve disminución de hematomas renales, con persistencia de signos de nefritis.

-Metabólico/Nutricional: durante la hospitalización se apoya con nutrición por sonda nasogástrica. Posterior a la extubación se inicia rehabilitación por fonoaudiología, logrando alimentación por vía oral.

-Profilaxis: inicialmente con tromboprofilaxis con HBPM. El 22/02 se inician dosis de anticoagulación por TEP subsegmentario. Se realiza traslape a TACO previo al alta, esquema provisorio 1mg vo de lunes a sábado (Domingo no)

Diagnósticos de ingreso:

- Síndrome febril agudo sin foco
 - Tratado con imipenem 7 días
- Insuficiencia respiratoria aguda severa hipoxémica recuperada
 - SDRA severo por COVID19 (FIS 07/2, Ag-COVID19 12/2)
 - VMI 15/2 al 25/2 (1 ciclo 48hrs de prono)
 - NAVM por P. aeruginosa MS + E. coli MS (CAET 23/2) tratada
 - TEP subsegmentario provocado de LID en tratamiento
- Coágulos en sistemas pielocaliciarios
- Delirium mixto resuelto
- ICC congestiva tratada
- FA paroxística de RVR resuelta (1 episodio)
- Antecedentes

Diagnóstico de Egreso

COVID-19, VIRUS IDENTIFICADO -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, estable afebril, hidratado
Orientado en tiempo espacio y persona
Sin LPP
Buena tolerancia oral
Sin req de o2 suplementario

UHD para KTM y KTR

Plan Post Alta

Reposo relativo

Fecha Epicrisis : 23/03/2022 15:59

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 23-03-2022 15:59:02

Página 3 de 3

Régimen hiposódico

Levotiroxina 25 mcg, 1 comprimido en la mañana en ayuna
Atorvastatina 40 mg, 1 comprimido al día
Aspirina 100 mg, 1 comprimido al día
Losartán 50 mg, 1/2 comprimido al día
Carvedilol 6.25mg, 1 comprimido cada 12 horas
Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 horas
Acenocumarol 4 mg, 1/4 de comprimido al día vo (De lunes a Sabado) domingo no.

Controles

Control en poli de TACO IC cursada

Control de patologías crónicas en CESFAM

Consultar en el SU en caso de fiebre $>38^{\circ}$, dolor que no ceda a analgesia, compromiso de conciencia o en caso de considerarlo necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

Aracely Aguayo Llanquileo

INTERNO

Becado/Residente



Romel Ríos Rivero

Médico Tratante (Staff)